

Apendicitis aguda

1. Introducción y relevancia clínica

La **apendicitis aguda** es la **causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en la infancia** y una **emergencia médica y quirúrgica**.

Corresponde a la **inflamación del apéndice cecal**, habitualmente secundaria a la **obstrucción luminal** por hiperplasia linfoide, fecalito o cuerpo extraño.

El diagnóstico precoz es fundamental, ya que el retraso puede conducir a **perforación, peritonitis y abscesos intraabdominales**.

En lactantes y preescolares el diagnóstico es más difícil, por cuadros atípicos y evolución rápida a perforación.

En el **EUNACOM**, este tema es un clásico: se presenta como un **niño con dolor abdominal que migra a fosa ilíaca derecha, fiebre y leucocitosis**, y la pregunta suele apuntar a la **conducta diagnóstica o quirúrgica correcta**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo fisiopatológico

1. **Obstrucción luminal** por fecalito, hiperplasia linfoide, parásitos o cuerpo extraño.
2. **Aumento de presión intraluminal** → compromiso del retorno venoso.
3. **Isquemia de la mucosa** → proliferación bacteriana.
4. **Necrosis y perforación** si no se trata a tiempo.

b. Microbiología

Flora mixta: *E. coli*, *Bacteroides fragilis*, *Peptostreptococcus*, *Pseudomonas*.

c. Secuencia anatómica

1. Apendicitis catarral (edematosa).

2. Flegmonosa.
 3. Gangrenosa.
 4. Perforada → peritonitis localizada o difusa.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Cuadro clínico típico (escolar y adolescente)

- **Dolor abdominal migratorio:**
 - Inicial periumbilical o epigástrico.
 - Luego localizado en **fosa ilíaca derecha (FID)**.
- **Anorexia y náuseas.**
- **Vómitos** (habitualmente después del dolor).
- **Fiebre moderada.**
- **Leucocitosis y desviación a izquierda.**

La **migración del dolor** es el signo más característico (hiperestesia cutánea en punto de McBurney).

b. En lactantes y preescolares

- Cuadro inespecífico: fiebre, irritabilidad, vómitos, distensión abdominal, rechazo alimentario.
 - Alta frecuencia de perforación al diagnóstico (>50 %).
-

c. En escolares y adolescentes

- Dolor localizado en FID, con signos de irritación peritoneal:

- Defensa muscular.
- Dolor a la descompresión (Blumberg +).
- Dolor al rebote o al movilizar la pierna derecha (signos de psoas, obturador o Rovsing).

d. Diagnóstico diferencial

Patología	Características distintivas
Adenitis mesentérica viral	Dolor FID postinfeccioso, sin anorexia, fiebre leve.
Gastroenteritis aguda	Diarrea predominante, sin migración del dolor.
Invaginación intestinal	Dolor intermitente, vómitos, sangre en heces.
Infección urinaria / pielonefritis	Disuria, piuria, urocultivo +.
Torsión ovárica / quiste roto	Adolescentes, dolor pélvico súbito.
Mekel divertículo inflamado	Similar a apendicitis; diagnósticos diferenciales quirúrgicos.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de apendicitis es **principalmente clínico**, apoyado por laboratorio e imagenología.

a. Laboratorio

- **Leucocitosis** ($>10.000\text{--}12.000/\text{mm}^3$) con desviación a izquierda.
- **PCR elevada.**
- **Orina simple:** puede mostrar piuria estéril por inflamación vecina.

La leucocitosis >15.000 y PCR >50 mg/L sugieren perforación.

b. Imagenología

Examen	Utilidad
Ecografía abdominal	Primera elección en niños. Alta sensibilidad y especificidad. Hallazgos: apéndice no compresible >6 mm, líquido libre, fecalito.
TAC abdominopélvico	Segunda elección, si ecografía no concluyente o sospecha de complicaciones.
Radiografía simple	Poca utilidad; puede mostrar niveles hidroaéreos o fecalito calcificado.

En Chile, el algoritmo recomendado es: **ecografía** → **TAC solo si duda diagnóstica.**

c. Escalas clínicas

Alvarado modificado (para pediatría):

Criterio	Puntaje
Dolor migratorio	1
Anorexia	1

Náuseas / vómitos 1

Dolor FID 2

Rebound 1

Fiebre >37,5 °C 1

Leucocitosis 2

Desviación a izquierda 1

Total máx. = 10

- **≤4:** improbable.
- **5–6:** observación / ecografía.
- **≥7:** probable → cirugía.

5. Tratamiento (según Guía MINSAL / SOCHIFE 2024)

a. Medidas iniciales

1. **Ayuno inmediato.**
2. **Hidratación EV** con suero fisiológico o Ringer Lactato.
3. **Antibióticos preoperatorios.**
4. **Analgesia** (no interfiere con diagnóstico).

5. Cirugía precoz (apendicectomía).

b. Antibioticoterapia

Antes de cirugía:

- Ampicilina + Gentamicina + Metronidazol, o
- Ceftriaxona + Metronidazol (esquema habitual en Chile).

Si apendicitis perforada o absceso:

- Mantener por 5–7 días postoperatorio.
 - Cubrir gramnegativos y anaerobios.
-

c. Tratamiento quirúrgico

- Apendicectomía: laparoscópica (preferida) o abierta.
 - Lavado peritoneal si perforada.
 - En absceso localizado: puede diferirse cirugía tras manejo antibiótico y drenaje.
-

d. Apendicitis complicada (perforada, abscesada)

- Hospitalización prolongada.
 - Antibioticoterapia 7–10 días.
 - Control ecográfico si absceso residual.
 - Cirugía diferida (“intervalar”) en casos seleccionados.
-

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- **Perforación** (riesgo ↑ en <5 años).
- **Peritonitis generalizada.**
- **Abscesos o flegmones periapendiculares.**
- **Obstrucción intestinal postoperatoria.**
- **Sepsis intraabdominal.**

b. Pronóstico

Excelente con diagnóstico precoz.

La mortalidad es <0,1 %.

El retraso diagnóstico es el principal factor de riesgo para perforación y complicaciones.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Dolor abdominal que migra a FID + anorexia + vómitos + fiebre = apendicitis aguda.**
2. El **diagnóstico es clínico**, apoyado por ecografía.
3. **Ecografía abdominal:** examen de elección inicial en niños.
4. **Antibióticos preoperatorios:** ceftriaxona + metronidazol.
5. **Cirugía precoz** evita perforación.
6. En niños pequeños, la **presentación es inespecífica** y el riesgo de perforación es alto.
7. **No retrasar cirugía** esperando confirmación de laboratorio o TAC.

☐ Errores frecuentes:

- Diagnosticar como gastroenteritis por presencia de vómitos.
- No realizar ecografía en dolor FID persistente.

- Postergar cirugía por síntomas atípicos.
 - No administrar antibióticos profilácticos.
 - No considerar apendicitis en niños <3 años.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **apendicitis aguda** es la **principal causa de abdomen agudo quirúrgico pediátrico**.
2. El **dolor migratorio a FID** es el signo más característico.
3. **Ecografía abdominal** es el examen inicial de elección.
4. **Tratamiento:** apendicectomía + antibióticos (ceftriaxona + metronidazol).
5. **No retrasar cirugía** por exámenes dudosos.
6. En <5 años, curso más rápido y riesgo alto de perforación.
7. Pronóstico excelente si se trata precozmente.